

SUPORT VITAL AVANÇAT (SVA) EN ADULTS

Algoritme de Tractament Segons les Noves Guies de l'European Resuscitation Council (ERC)
2025

PAS 1: AVALUACIÓ INICIAL I ACCIONS IMMEDIATES

Pacient inconscient i amb respiració absent o anormal ⇒ Activar CODI 0 (Telèfon:2222) i/o SEM

Iniciar RCP 30:2 | Connectar Desfibril·lador/Monitor | Minimitzar al màxim les interrupcions

AVALUAR EL RITME CARDÍAC (Aturar compressions < 5 segons)



RITME DESFIBRILLABLE

FV / TV Sense Pols

- **1 Descàrrega Immediata:**
 - Mínim de 150J (bifàsica exponencial).
 - Continuar compressions mentre es carrega.
- **Reprendre la RCP immediatament:**
 - Fer 2 minuts de RCP abans de reavaluar.
 - No aturar-se per comprovar el pols o ritme.
- **Medicació Post-3^a Descàrrega:**
 - **Adrenalina 1 mg IV/IO** després del 3r xoc. Repetir cada 3–5 minuts (cada 2 cicles de RCP).
 - **Amiodarona 300 mg IV/IO** després del 3r xoc. Donar dosi addicional de 150 mg després del 5è xoc.
- **Optimització de Posició i Vector:**
 - Assegurar posició àpex-lateral correcta.
 - Si 3 descàrregues són ineficaces, considerar el canvi de vector (posició antero-posterior).



RITME NO DESFIBRILLABLE

AESP / Asistòlia

- **Medicació Immediata:**
 - **Adrenalina 1mg IV/IO** de manera immediata (tan aviat com es disposi d'accés vascular).
 - No demorar la primera dosi d'Adrenalina.
- **Reprendre la RCP immediatament:**
 - Fer 2 minuts de RCP (30:2) amb compressions d'alta qualitat i ventilació efectiva.
- **Medicació Continuada:**
 - Repetir **Adrenalina 1mg IV/IO** cada 3–5 minuts (aproximadament cada 2 cicles de RCP).
- **Cerca i Tractament de Causes:**
 - Identificar i corregir de manera prioritària les causes reversibles (4H i 4T).
 - Avaluat si hi ha signes de retorn a circulació espontània in cada pausa.

RETORN DE LA CIRCULACIÓ ESPONTÀNIA (RCE)

- **Abordatge ABCDE de seguretat.**
- **Oxigenació i ventilació:** Objectiu SpO₂ d'ona de 94–98% i PaCO₂ en rang normal.
- **Support Hemodinàmic:** Mantenir Pressió Arterial Sistòlica (PAS) > 100 mmHg.
- **ECG de 12 derivacions:** Valorar angiografia coronària o intervenció coronària percutània (ICP).
- **Control de Temperatura:** Evitar la febre i controlar la temperatura segons el protocol post-aturada.
- **Tractament etiològic:** Identificar i resoldre els problemes cardíacs de fons.

CAUSES REVERSIBLES: LES 4H I LES 4T

Les 4H:

- Hipòxia
- Hipovolèmia
- Hiper/hipopotassèmia
- Hipotèrmia/hipertèrmia

Les 4T:

- Toxines (sobredosi)
- Taponament cardíac
- Tensió pneumotòrax
- Trombosi (coronària/pulm)

Ecografia Clínic-Assistencial (POCUS): Utilitzar en mans expertes per detectar taponament, pneumotòrax o hipovolèmia.

No ha de generar retards en les compressions toràciques.

ACCIONS DE QUALITAT I NOVES RECOMANACIONS

- **Compressions d'Alta Qualitat:** Freqüència de 100–120 l.p.m. i profunditat de 5–6 cm. Evitar la hiperventilació i optimitzar el retorn elàstic.
- **Accés Vascular Primari:** Intentar sempre l'accés intravenós (IV) en primera instància. Si no es pot aconseguir ràpidament després de 2 intents, canviar a la via intraòssia (IO).
- **Via Aèria Avançada i Capnografia:**
 - S'aconsella l'ús de dispositius supraglòtics (SGA) com i-gel (preferit davant del tub laringi).
 - La capnografia d'ona (ETCO₂) contínua és obligatòria per confirmar el tub i descartar intubació esofàgica.
- **Fàrmacs Desaconsellats de forma Rutinària:** No s'ha d'administrar de manera sistemàtica calci, bicarbonat de sodi ni corticoides.